EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92504
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-09-10 14:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLOS DEL CARMEN ARIAS ANDRADE			RUN	: 4.252.736-K
F.Nac	: 11-12-2022	Edad	: 1 AÑO, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-03	Fecha Egreso	: 2024-09-10 14:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10.XS-HIPERTENSION ARTERIAL SEVERA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa el 03.09.24 por cuadro de compromiso del estado general, asociado a compromiso cuantitativo de conciencia. Además relata hematuria de 1 semana de evolución. Se pregunta dirigidamente por tos y expectoración a lo que familiar refiere que está en su basal, con expectoración blanquecina.
A urgencias ingresa taquipneico e hipertenso.
Se realizan exámenes de laboratorio dentro de los que destaca PCR 61, crea 2.6, BUN 40, ELP (n), pH 7.35, pCO2 48, pO2 69 (PAFI 191 con FIO2 36%), glicemia 350. Tropo 49
Se realiza TAC de tórax en el que se ve derrame pleural bilateral con engrosamiento septal y focos de relleno alveolar a izquierda, asociado a opacidades en vidrio esmerilado.
Para estudio de compromiso de conciencia se realiza tac de cerebro que informa infartos subagudos con compromiso cortical fronto parietales bilaterales y temporo-occipitales e Infartos antiguos cerebelosos.
Se decide hospitalizar para manejo O2 y de PA con NTG a la espera de titulación de antihipertensivos orales, terapia ATB y depleción de volumen.
En UTI:
En lo hemodinamico, inicialmente con BIC de NTG, a la espera de titulación de antihipertensivos orales, la cual se suspende dentro de las primeras 48 hrs. ProBNP de ingreso en 19000 y signos congestivos, por lo que se inicia terapia depletiva. Al segundo día de hospitalización cursa con FA con RVR por lo que se inicia betabloqueo y acenocumarol (contraindicado DOAC por ERC). Actualmente persiste con FA, con frecuencia cardiaca adecuada.
En lo infeccioso, TAC de ingreso compatible con neumonía. Se inicia tto con ceftriaxona, completado 7 días de tratamiento. Actualmente con parámetros inflamatorios bajos, sin disnea.

Ha mantenido función renal dentro del basal (crea entre 2.6-3.0), sin trastorno electorlitico. Diuresis adecuada.
En condiciones de traslado a Hospitalización domiciliaria para traslape a TACO (Acenocumarol): INR hoy 1.54

PLAN DE MANEJO:

- Hemodinamia: Ecocardiograma ambulatorio. Betabloqueo + TACO por FA. Traslado a HODOM para titular dosis de acenocumarol para INR 2-3
- Infeccioso: Tratamiento antibiotico por Neumonía completado. Actualmente sin conflicto infeccioso
- Nefro: En su basal. Seguimiento ambulatorio en APS. Derivar a nefrología en caso de mayor deterioro. Evitar antiinflamatorios y alimentos ricos en potasio. Evitar exceso de sal y ojalá las carnes rojas (favorecer consumo de carnes blancas y huevo)
- Metabólico: Regimen diabético hiposódico. Ha mantenido glicemias en rango para paciente hospitalizado con diabetes. Titular dosis de insulina NPH en HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen hiposódico diabético
3.
4. Omeprazol 20 mg/día vo
5. Aspirina 100 mg/día vo
6. Amlodino 10 mg/día vo
7. Furosemida 40 mg/día vo
8. Isosorbide 10 mg c/6 hrs vo
9. Metildopa 500 mg c/8 hrs vo
10. Atorvastatina 40 mg/día vo
11. Bromuro de Ipratropio 4 puff c/6 hrs c/AC
12. Acenocumarol según INR 2mg hoy.
13. Latanoprost 1 gota en cada ojo por noche
14. Insulina NPH 20 U AM - 10 U PM sc
15. Control en CESFAM en 15 días
16. Derivar a cardiología
17. Derivar a Nefrología
18. Se tramitará ecocardiograma

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/09/24: INR 1.54
09/09/24: Crea 2.8, ELP 142/3.3/107, INR 1.14
08/09/24: Crea 3.2 Uremis 172, ELP 141/2.9/104 GB 7600 Hb 11.4 Hto 32% PQT 280mil GSA 7.47 pCO2 41 pO2 87 HCO3 31 SaO2 94%
07/09/24: Crea 3.3, PCR 20, Urea 173, ELP 137/3.2/100
06/09/24: Crea 2.8 VFG 21 PCR 32.9 ELP 139/3.2/99 Hb 11.3 GB 7600 Plaq 268000 INR 1.09 TTPK 27
05/09/24: Glicemia 101 Crea 2.7 lactato 0.8 PCR 55 Uremia 120 ELP 137/3.4/100 Hb 11.5 Hto 33.4% GB 7900 PQT 256mil ProBNP 19730
GSA pH 7.44 pO2 70.8 pCO2 40.5 HCO3 27.9
04/09/24: Alb 3.3 Crea 2.6 PCR 89 Uremia 106 ELP 135/4/100 Hb 11.3 Hto 33% PQT 227 mil GSA pH 7.42 pO2 69 pCO2 43 HCO3 28% FiO2 32%
*Crea abril/24 2.1 VFG 30

Control en: 15 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

Nicolás Mella Torres
MEDICO TRATANTE
16447403-8

JEFE SERVICIO